TEMA 6 · Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS)

Resumen OPE Enfermería SMS · Profesiones sanitarias, ejercicio profesional, formación sanitaria especializada y continuada, desarrollo profesional y ejercicio privado

Siglas y leyes de este tema

Sigla o norma	Nombre completo	De qué va
LOPS (Ley 44/2003)	Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias	Todo el tema
SNS / SMS	Sistema Nacional de Salud / Servicio Murciano de Salud	
CC. AA.	Comunidades Autónomas	
CE	Constitución Española	
REPS	Registro Estatal de Profesionales Sanitarios	Quién está habilitado y dónde trabaja
TCAE	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería	FP de grado medio
FSE	Formación Sanitaria Especializada	Las especialidades por residencia
MIR / EIR / FIR / PIR	Médico / Enfermero / Farmacéutico / Psicólogo Interno Residente	Residentes de cada profesión
ACE	Área de Capacitación Específica	Ultraespecialización dentro de una especialidad
DA / DAA	Diploma de Acreditación / Diploma de Acreditación Avanzada	Formación continuada en áreas transversales
CFC	Comisión de Formación Continuada	Acredita cursos con créditos
RD 1146/2006	Real Decreto de la relación laboral especial de residencia	El contrato del residente
RD 450/2005	Real Decreto de especialidades de Enfermería	Las 7 especialidades
RD 183/2008	Real Decreto de especialidades en Ciencias de la Salud y FSE	Comisión de Docencia, tutores, supervisión

1. Objeto, ámbito y REPS

- **Ley 44/2003, de 21 de noviembre**, de ordenación de las profesiones sanitarias (LOPS): la "constitución sectorial" de los recursos humanos en salud. Principios: corresponsabilidad, formación permanente, calidad y **seguridad del paciente**.
- Ámbito **universal**: obliga a todos los profesionales sanitarios, en el sector **público y en el privado**.
- **Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS)**: registro **público** con identidad, titulación, especialidad y lugar de ejercicio. Lo alimentan ministerios, Comunidades Autónomas (CC. AA.), colegios y centros públicos y privados. Permite al ciudadano verificar quién le atiende y combate el intrusismo.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La LOPS **no** es solo para la sanidad pública: también rige en clínicas y mutuas privadas.

2. Clasificación de las profesiones sanitarias

Grupo	Profesiones
Art. 2 · Licenciados / grado superior	**Medicina, Farmacia, Odontología y Veterinaria**

Grupo	Profesiones
Art. 2 · Diplomados / grado	**Enfermería**, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Podología, Óptica y Optometría, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética
Art. 3 · FP grado superior	Técnicos superiores: Dietética, Higiene Bucodental, Anatomía Patológica y Citología, Radioterapia, Imagen para el Diagnóstico, Audiología Protésica (Grupo B)
Art. 3 · FP grado medio	**TCAE** (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería)

- La **Veterinaria** es profesión sanitaria universitaria por su papel en salud pública, zoonosis y seguridad alimentaria.
- El art. 3 se ampara en el **art. 35.1 de la Constitución (CE)** (derecho al trabajo y libre elección de profesión). El art. 5 obliga a integrar a los técnicos y a darles formación continuada.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Los técnicos superiores de FP están en el **art. 3**, no son titulados universitarios.

3. Ejercicio profesional (Título I, arts. 4-11)

- **Art. 7.2.a · Enfermería**: le corresponde **la dirección, evaluación y prestación de los cuidados** orientados a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud y a la prevención. Es **autonomía técnica y funcional**: no es una profesión subordinada.
- Art. 7.2.b · Fisioterapia: tratamientos con medios y agentes físicos.
- **Art. 9**: trabajo en **equipo**, corresponsabilidad y delegación justificada, con historia clínica compartida.
- **Gestión clínica (art. 10)**: son funciones de gestión clínica la jefatura o coordinación de unidades, las tutorías y la organización de la formación, y la participación en comités de calidad, seguridad o ética. Los medios de acceso los fijan las **Administraciones sanitarias, los Servicios de Salud o los órganos de gobierno de los centros**, con participación de los profesionales, por sistemas objetivos y transparentes; su desempeño se evalúa periódicamente. **Art. 11**: la estructura asistencial debe estar disponible para docencia e investigación.

Requisitos para ejercer (art. 4)

1. **Título oficial** habilitante.
2. **No estar inhabilitado** ni suspendido (por sentencia o sanción colegial firme).
3. **Colegiación** cuando una ley estatal la exija (Enfermería: obligatoria también en la sanidad pública).

- Los **colegios profesionales** son **corporaciones de Derecho Público**: control deontológico y de la buena praxis. Su sanción firme de inhabilitación impide ejercer **en cualquier ámbito**, también en el SMS.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Trabajar en el SMS con plaza fija **no** exime de estar colegiada.

4. Formación de grado (Título II, cap. I-II)

- **Art. 12**: revisión permanente de la formación (evidencia, necesidades de la población, seguridad del paciente, evaluación de calidad).
- **Art. 13 · numerus clausus**: lo fijan los **Ministerios de Sanidad y Educación** (oído el Foro Profesional) según las **necesidades del SNS** y la **capacidad docente** de los centros.
- **Art. 14 · conciertos** universidad-servicio de salud: dan la condición de **Hospital Universitario** (sigue perteneciendo al SMS). Figuras: **profesor asociado** de Ciencias de la Salud (mantiene su plaza asistencial) y **plazas vinculadas** (un único nombramiento como clínico del SMS y profesor de universidad).

5. Formación Sanitaria Especializada (FSE, arts. 15-32)

- Carácter **oficial y estatal**, por **sistema de residencia** (MIR, EIR, FIR, PIR...) con **contrato de residencia**, una relación laboral de carácter especial (**RD 1146/2006**). En este contrato **no puede haber periodo de prueba**.

- **Supervisión decreciente** (art. 15 del RD 183/2008): el residente de primer año tiene supervisión **directa y de presencia física**; después, de proximidad y de respaldo. La responsabilidad legal crece de forma progresiva.
- **Libro del Residente**: registro obligatorio de rotaciones, guardias, técnicas y evaluaciones.
- El **título de especialista** lo expide el **Ministerio de Sanidad** (en nombre del Rey), no la Comunidad Autónoma.

Especialidades de enfermería (RD 450/2005)

- Acceso por **examen EIR** estatal; **2 años** de residencia en unidad docente acreditada; evaluaciones anuales y final.
- Desarrolladas: **Obstétrico-Ginecológica (Matrona)**, **Familiar y Comunitaria**, **Salud Mental**, **Pediátrica**, **Geriátrica** y **del Trabajo**. **Cuidados Médico-Quirúrgicos**: recogida en la norma pero **sin desarrollar** (nunca se ha ofertado).

Segunda especialidad y ACE

- **Segunda especialidad (art. 23)**: exige **5 años** de ejercicio como especialista, que la nueva sea **del mismo tronco** y superar una prueba; el programa se adapta (la residencia se acorta). Para la tercera deben pasar **8 años** desde el título anterior.
- **Áreas de Capacitación Específica (ACE, arts. 24-25)**: ultraespecialización sobre una especialidad; exigen **2 años** de ejercicio en ella. Dan un **diploma** (no un nuevo título); ratio **1 tutor : 1 residente**.

Estructuras docentes

Órgano	Claves
Comisión de Docencia (art. 27; RD 183/2008 de especialidades y FSE)	Preside el **Jefe de Estudios** (voto de calidad); vocales tutores y residentes (elegidos por **voto directo y secreto**); secretario administrativo **sin voto**. Quórum: mitad más uno; acuerdos por **mayoría simple**. Planifica, autoriza rotaciones, certifica evaluaciones e informa en expedientes disciplinarios
Tutor	Especialista de plantilla **acreditado** (el tutor "accidental" no existe). Derecho a tiempo protegido, formación y sustitución inmediata
Comisiones Nacionales de Especialidad (art. 28)	Una por especialidad: elaboran el **programa formativo**, los criterios de evaluación, auditan unidades docentes y proponen ACE. Incluyen **2 vocales residentes**, con mandato de **2 años**
Consejo Nacional de Especialidades (art. 30)	Reúne a los presidentes de las Comisiones Nacionales; asesora a los Ministerios

Estudiantes y residentes ante el paciente (Orden SSI/81/2017, protocolo de intimidad)

- Antes de cada acto se informa al paciente y se pide su **consentimiento verbal**; si **se niega**, el personal en formación **no está presente** (da igual que el hospital sea universitario). Se puede pedir un **consentimiento global** por un periodo **no superior a 15 días**.
- Como máximo **3 alumnos o 3 residentes por paciente** en un acto clínico (salvo que el paciente consienta más).
- **Tarjeta identificativa** visible, que da la dirección del centro y se **devuelve** al terminar. Todos firman al empezar un **compromiso de confidencialidad**.
- Los residentes tienen **acceso directo al paciente desde el 2.º año**, de forma progresiva y según indique su tutor. Se recomienda que los alumnos practiquen antes con **simulación**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **La Comisión de Docencia la preside el Jefe de Estudios, nunca el Gerente ni la Dirección de Enfermería.**
>
> ! El programa formativo lo redacta la **Comisión Nacional** de la especialidad; el hospital lo aplica.

6. Formación continuada (arts. 33-36)

- Proceso de aprendizaje **activo y permanente**, dinámico, de desarrollo de la profesionalidad: un **compromiso** del profesional para mantener al día su competencia y una motivación añadida. Es a la vez **derecho** y **deber** de **todos** los profesionales sanitarios (no solo de los especialistas). La Administración debe facilitarla (planes, recursos, conciliación horaria).
- **Comisión de Formación Continuada del SNS (CFC, art. 34)**: criterios comunes de acreditación. Los **créditos CFC** valen en **todo el SNS**, la acredite la CA que la acredite.

- **Diplomas de Acreditación (DA) y de Acreditación Avanzada (DAA) (art. 36)**: certifican competencias en áreas funcionales transversales (dolor, paliativos, trasplantes). El DAA exige el DA previo. Según el manual, **vigencia de 5 años** y renovación.

7. Desarrollo profesional, ejercicio privado y Foro Profesional

- **Carrera profesional (Título III, arts. 37-39)**: reconocimiento **horizontal** e individual de conocimientos, experiencia y objetivos, **sin cambiar de puesto**. **Art. 38**: las CC. AA. deben **homologar** los grados entre sí (movilidad sin perder el nivel).
- **Ejercicio privado (Título IV, arts. 40-46)**: por cuenta propia o ajena, con los **mismos controles de calidad** que el SNS (historia clínica, consentimiento, bioseguridad).
- **Art. 46**: es **obligatorio** tener un **seguro de responsabilidad civil**, aval u otra garantía financiera para la asistencia en el sector privado.
- **Foro Profesional (Título V, arts. 47-50)**: Ministerios de Sanidad y Educación, CC. AA., colegios y sindicatos. Resuelve conflictos competenciales entre profesiones, participa en las normas y vela por la acreditación de la FSE.

TRAMPAS DE EXAMEN

! Seguro de responsabilidad civil en la privada = **obligatorio** (art. 46).

! La carrera profesional permite progresar **sin** pasar a un puesto de gestión.

Otras preguntas del test de este tema

Estas preguntas del EIR caen en el test de este tema aunque su materia es de otros apartados del programa. Aquí tienes lo necesario para responderlas.

Indicación enfermera (RD 954/2015, modificado por el RD 1302/2018; tema completo: el 22)

Qué	Cómo
Medicamentos no sujetos a prescripción y productos sanitarios (art. 2)	La enfermera los indica **de forma autónoma**, con una orden de dispensación
Medicamentos sujetos a prescripción médica (art. 3)	Solo **conforme a protocolos o guías** de práctica clínica, en trabajo **colaborativo** con el médico (nunca de forma autónoma)
Vacunas del calendario y de campañas (art. 3.3)	Basta la **orden de dispensación** enfermera (salvo que el paciente necesite valoración médica individual)

- En ambos casos, la enfermera de cuidados generales y la especialista necesitan una **acreditación** que emite la **Comunidad Autónoma**.
- **Requisitos de la acreditación (art. 9)**: título de Grado, Diplomado en Enfermería o ATS **y** una de estas dos cosas: **1 año de experiencia** profesional **o** un **curso de adaptación gratuito** de la Administración. Para cuidados especializados, además el título de especialista. **Excepcionalmente**, quien no tenga esos títulos pero ya hiciera indicación por normativa autonómica previa también puede acreditarse. A las enfermeras de otros países de la UE **no** se les reconoce automáticamente: deben justificar los mismos requisitos.
- Competencias exigidas (anexo I): conocer los grupos de fármacos y su mecanismo de acción; conocer los productos sanitarios de los cuidados; indicación y uso de medicamentos evaluando beneficios y riesgos; y manejar las tecnologías de la información. (El SMS en 2019 dio por falsa una versión de la tercera con las palabras cambiadas de orden.)
- **Guías**: las elabora la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial y las valida la Dirección General de Salud Pública. Definen qué medicamentos sujetos a prescripción puede indicar la enfermera, en qué situaciones y de forma protocolizada (iniciar, modificar la pauta, prorrogar o suspender). Publicadas: **heridas** (Resolución de 20 de octubre de 2020), quemaduras, ostomías, hipertensión y diabetes tipo 1 y 2. De forma **excepcional**, ante medicamentos de especial complejidad, pueden exigir **formación complementaria**.
- La orden de dispensación lleva el **número de colegiada** (o el código del SNS) y, si la tiene, la especialidad.
- El RD se aplica igual en la sanidad **pública y privada**.

Otros datos

- **Cartera de servicios comunes del SNS** (Ley 16/2003, tema 4): conjunto de técnicas, tecnologías y procedimientos con los que se hacen efectivas las prestaciones; garantiza la atención integral y la continuidad. Las CC. AA. **sí pueden añadir** técnicas que no estén en la común (cartera complementaria, con fondos propios).
- **Ley 16/2003, art. 4**: el ciudadano **desplazado** a otra comunidad recibe allí la asistencia en las **mismas condiciones que los residentes de esa comunidad**.
- **Consejo Interterritorial del SNS** (art. 73 de la Ley 16/2003): sus acuerdos se plasman en **recomendaciones** aprobadas **por consenso**.
- **Doctorado** (RD 99/2011, modificado por el RD 576/2023): se accede con Grado + Máster (300 créditos ECTS) o, entre otras vías, con **otro título de Doctor** o con al menos **2 años** de residencia superados con evaluación positiva. Dura como máximo **4 años** a tiempo completo (7 a tiempo parcial).
- **Plan de Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias** (Gobierno, 2018): sacar las pseudoterapias de los centros sanitarios, informar con veracidad, perseguir la publicidad engañosa y que no se enseñen en la universidad. El EIR dio como objetivo correcto que estas prácticas solo puedan hacerlas **profesionales sanitarios titulados** (Grado o equivalente) y habilitados, **bajo su propia responsabilidad**.